

QCM - Motilité oculaire et strabisme

40 questions couvrant les cours : Introduction au strabisme, Les strabismes concomitants, Physiopathologie et classification des strabismes, et Malvoyance chez l'enfant.

Question 1 - Quelle est la définition de l'axe visuel ?

- A. La ligne joignant le pôle postérieur et le centre de la cornée
- B. La ligne joignant la fovéa et le point de fixation, en passant par le point nodal de l'œil
- C. L'angle formé entre l'axe anatomique et l'axe pupillaire
- D. La ligne perpendiculaire au plan de la rétine passant par le centre optique

Question 2 - L'angle kappa est défini comme :

- A. L'angle entre les deux axes visuels
- B. L'angle entre l'axe visuel et l'axe anatomique
- C. L'angle de déviation mesuré au cover test
- D. L'angle de convergence en vision de près

Question 3 - Lors de la méthode aux reflets (test de Hirschberg), l'orthophorie est définie par :

- A. Des reflets cornéens asymétriques par rapport à l'arête nasale
- B. Des reflets cornéens symétriques par rapport à l'arête nasale
- C. Un mouvement de refixation à la levée de l'occlusion
- D. L'absence de reflets cornéens lors de l'illumination

Question 4 - L'hétérophorie se distingue de l'hétérotropie en ce que :

- A. L'hétérophorie est une déviation manifeste permanente
- B. L'hétérophorie est une tendance à la déviation uniquement lorsque la fusion est bloquée
- C. L'hétérophorie entraîne toujours une amblyopie
- D. L'hétérophorie est caractérisée par une déviation verticale

Question 5 - Les ductions sont des mouvements oculaires :

- A. Binoculaires conjugués dans la même direction
- B. Binoculaires de sens opposés
- C. Monoculaires d'un seul œil (adduction, abduction, élévation, abaissement)
- D. Réflexes déclenchés par l'inclinaison de la tête

Question 6 - Les vergences sont des mouvements oculaires binoculaires :

- A. Simultanés et conjugués dans la même direction
- B. Simultanés et de sens opposés
- C. Monoculaires de l'œil directeur
- D. Exclusivement verticaux

Question 7 - La loi de Sherrington d'innervation réciproque stipule que :

- A. Une quantité égale d'influx nerveux est transmise aux muscles synergiques controlatéraux
- B. L'augmentation de l'influx d'un muscle est accompagnée d'une diminution de l'influx de son antagoniste
- C. Tout mouvement oculaire est précédé d'un mouvement de la tête
- D. Les muscles agonistes reçoivent toujours le même influx nerveux que les antagonistes

Question 8 - La loi de Hering d'innervation égale concerne :

- A. L'inhibition réciproque entre muscles agoniste et antagoniste du même œil
- B. L'innervation symétrique des muscles controlatéraux synergiques lors des mouvements conjugués
- C. La relation entre accommodation et convergence
- D. La torsion oculaire lors de l'inclinaison de la tête

Question 9 - Lors de l'apparition d'un strabisme, la confusion est due au fait que :

- A. Les deux maculas reçoivent les images de deux points différents, extériorisés au même endroit
- B. L'image est vue double car les axes visuels ne sont plus parallèles
- C. L'œil dévié ne perçoit plus aucun stimulus visuel
- D. La rétine périphérique de l'œil dominant est supprimée

Question 10 - La correspondance rétinienne anormale (CRA) est :

- A. Un phénomène négatif correspondant à la suppression de l'image de l'œil dévié
- B. Un phénomène positif d'adaptation : modification des références spatiales de la rétine de l'œil dévié pour éviter la diplopie
- C. Une méthode thérapeutique de rééducation orthoptique
- D. Une forme particulière d'amblyopie fonctionnelle

Question 11 - Un strabisme concomitant se caractérise par :

- A. Une déviation variable selon la direction du regard, liée à une paralysie musculaire
- B. Une déviation constante dans toutes les directions du regard avec une motilité oculaire conservée
- C. Une limitation des mouvements oculaires dans au moins une direction
- D. Une diplopie permanente difficile à corriger

Question 12 - Chez l'enfant strabique, pourquoi la diplopie est-elle rarement présente ?

- A. Car l'enfant n'a pas encore de vision binoculaire développée
- B. Car le cerveau met en place des mécanismes d'adaptation comme la suppression de l'image de l'œil dévié
- C. Car le strabisme de l'enfant est toujours intermittent
- D. Car la fixation fovéale n'est pas encore établie avant 3 ans

Question 13 - Parmi les classifications des strabismes concomitants, selon la direction de la déviation on distingue :

- A. Les ésootropies (déviation vers l'extérieur) et les exotropies (déviation vers l'intérieur)
- B. Les ésootropies (déviation vers l'intérieur) et les exotropies (déviation vers l'extérieur)
- C. Les hypertropies (déviation vers le haut) et les hypotropies (déviation vers le bas)
- D. Les tropies (manifestes) et les phories (latentes)

Question 14 - Lors du cover test alterné, quel mouvement indique la présence d'une tropie (strabisme manifeste) ?

- A. Un mouvement de refixation de l'œil découvert lors de la levée de l'occlusion de l'autre œil
- B. L'absence de tout mouvement lors de l'occlusion
- C. Un mouvement de torsion lors du passage d'un œil à l'autre
- D. Un clignement excessif lors de l'occlusion

Question 15 - L'ésotropie accommodative est principalement liée à :

- A. Une myopie forte non corrigée entraînant une divergence excessive
- B. Une hypermétropie non corrigée entraînant une accommodation excessive et une convergence excessive
- C. Un syndrome de rétraction musculaire
- D. Une paralysie du nerf VI

Question 16 - L'ésotropie infantile se caractérise notamment par :

- A. Son apparition après l'âge de 3 ans et un petit angle de déviation
- B. Son apparition avant 6 mois, un angle important, souvent associée à un nystagmus latent
- C. Sa correction complète par lunettes
- D. Sa survenue exclusivement chez les enfants hypermétropies

Question 17 - L'exotropie intermittente se manifeste préférentiellement lors de :

- A. La vision de près et lors d'une forte attention
- B. La fatigue, l'inattention, la forte luminosité et la fixation au loin
- C. La lecture intensive et le travail sur écran
- D. La nuit ou dans un environnement peu éclairé

Question 18 - Le microstrabisme se distingue des autres strabismes par :

- A. Un angle de déviation très important, souvent supérieur à 30 dioptries prismatiques
- B. Un angle de déviation faible (< 10 DP), difficile à voir à l'inspection, souvent associé à une CRA
- C. Une limitation totale des mouvements oculaires
- D. Une diplopie permanente et invalidante

Question 19 - Le traitement de l'amblyopie repose principalement sur :

- A. La chirurgie des muscles oculomoteurs

- B. L'occlusion de l'œil dominant pour stimuler l'œil amblyope
- C. L'administration de collyres mydriatiques dans l'œil amblyope
- D. La rééducation binoculaire par synoptophore

Question 20 - La chirurgie des strabismes concomitants est indiquée lorsque :

- A. Le diagnostic de strabisme est posé, quelle que soit la prise en charge médicale
- B. La déviation persiste malgré une prise en charge bien conduite (correction optique, traitement de l'amblyopie)
- C. L'enfant présente une ésoptropie accommodative avec une forte hypermétropie
- D. Le patient a moins de 1 an

Question 21 - Selon l'OMS, une déficience visuelle est définie par une acuité visuelle inférieure à :

- A. 5/10 avec correction optique
- B. 3/10 avec correction optique
- C. 1/10 avec correction optique
- D. 10/10 sans correction optique

Question 22 - Le champ visuel normal commun aux deux yeux s'étend sur :

- A. 90° de large et 60° verticalement
- B. 360° de large et 180° verticalement
- C. 180° de large et 130° verticalement
- D. 120° de large et 90° verticalement

Question 23 - Le glaucome congénital se caractérise par :

- A. Une opacité du cristallin présente dès la naissance
- B. Une anomalie de développement de l'angle irido-cornéen empêchant l'évacuation de l'humeur aqueuse
- C. Une dégénérescence des photorécepteurs rétiniens
- D. Une prolifération vasculaire anormale de la rétine

Question 24 - Quel est le signe de découverte le plus fréquent de la cataracte congénitale ?

- A. La photophobie
- B. Le larmoiement clair
- C. La leucocorie (reflet blanc de la pupille)
- D. La mégaloconée

Question 25 - Le rétinoblastome est :

- A. Une dystrophie rétinienne héréditaire touchant les photorécepteurs
- B. La tumeur maligne primitive de la rétine la plus fréquente chez l'enfant, dont le signe d'appel est la leucocorie

- C. Une complication du glaucome congénital non traité
- D. Une forme de rétinopathie du prématuré sévère

Question 26 - La rétinopathie du prématuré est liée à :

- A. Une anomalie génétique du développement de la mélanine
- B. Un trouble prolifératif des vaisseaux sanguins de la rétine en développement chez les nourrissons prématurés
- C. Une accumulation de lipofuscine dans les cellules de l'épithélium pigmentaire
- D. Une dystrophie maculaire juvénile à transmission autosomique récessive

Question 27 - La maladie de Stargardt est :

- A. La dystrophie maculaire juvénile la plus fréquente, de transmission autosomique récessive
- B. Une pathologie liée à un déficit en mélanine
- C. Un syndrome associant perte auditive et perte visuelle
- D. Une cataracte congénitale bilatérale à transmission autosomique dominante

Question 28 - L'albinisme est caractérisé par :

- A. Une prolifération excessive de mélanine entraînant une photophobie sévère
- B. Une absence partielle ou totale de mélanine, entraînant une dépigmentation et une mauvaise acuité visuelle
- C. Une opacification du cristallin due à un déficit enzymatique
- D. Une atteinte des photorécepteurs de type cônes exclusivement

Question 29 - Le test de Hirschberg (reflets cornéens) chez l'enfant permet de :

- A. Mesurer précisément l'angle de déviation en dioptries prismatiques
- B. Évaluer la stéréoscopie et la vision binoculaire
- C. Dépister un strabisme en vérifiant la centration des reflets cornéens lors d'une illumination frontale
- D. Éliminer une anomalie de réfraction sous cycloplégie

Question 30 - Parmi les aides visuelles suivantes, laquelle permet les grossissements les plus importants (jusqu'à 50 fois) ?

- A. Les loupes grossissantes à main
- B. Les verres filtrants spécifiques
- C. Les télé-loupes montées sur lunettes (systèmes Galilée ou Kepler)
- D. Les agrandisseurs électroniques (associant caméra et écran)

Question 31 - La triade proximale regroupe trois phénomènes neurologiquement couplés, lesquels ?

- A. Accommodation, convergence et myosis
- B. Fusion, vergence et accommodation
- C. Fixation, poursuite et saccade

D. Convergence, divergence et torsion

Question 32 - Quelle est la différence entre une phorie et une tropie ?

- A. La phorie est une déviation visible spontanément ; la tropie est compensée par la fusion
- B. La phorie est compensée par la fusion (latente) ; la tropie est visible spontanément (manifeste)
- C. La phorie est toujours horizontale ; la tropie est toujours verticale
- D. La phorie n'est détectable qu'au synoptophore ; la tropie est détectable au cover test

Question 33 - Dans un strabisme non concomitant, la déviation :

- A. Est identique dans toutes les directions du regard et la motilité est conservée
- B. Varie selon la direction du regard et traduit une atteinte musculaire ou neurologique
- C. Est uniquement présente lors de la vision de près
- D. Disparaît complètement avec la correction optique

Question 34 - Le torticollis compensateur dans le strabisme paralytique permet au patient de :

- A. Augmenter l'acuité visuelle de l'œil atteint
- B. Adopter une position de tête pour éviter la diplopie
- C. Réduire l'angle de déviation en stimulant la fusion
- D. Prévenir le développement de l'amblyopie

Question 35 - Le strabisme accommodatif pur se caractérise par :

- A. Une déviation non corrigée par les lunettes, nécessitant une chirurgie
- B. Une déviation totalement corrigée par la correction optique adaptée
- C. Une déviation présente uniquement en vision de loin
- D. Une composante non accommodative associée persistant malgré la correction optique

Question 36 - La paralysie du nerf VI (nerf abducens) entraîne :

- A. Un déficit d'adduction avec exotropie
- B. Un déficit d'abduction avec ésoptropie, car le droit latéral est paralysé
- C. Un déficit de l'élévation avec hypotropie
- D. Un déficit de la convergence avec exophorie

Question 37 - Un strabisme intermittent se caractérise par :

- A. Une déviation constante et permanente sans phase de réalignement
- B. Une déviation non constante avec alternance de phases alignées et de phases de déviation, car le système de fusion fonctionne encore partiellement
- C. Une déviation apparaissant uniquement en vision de près
- D. Une suppression unilatérale permanente entraînant une amblyopie sévère

Question 38 - Le strabisme sensoriel est secondaire à :

- A. Une hypermétropie forte bilatérale non corrigée

- B. Une baisse de vision unilatérale, quelle qu'en soit la cause, empêchant le maintien de l'alignement oculaire
- C. Une paralysie congénitale d'un muscle oculomoteur
- D. Un syndrome de rétraction musculaire (syndrome de Duane)

Question 39 - Dans la physiopathologie générale du strabisme, le déséquilibre repose sur l'interaction de trois systèmes, lesquels ?

- A. Visuel, auditif et proprioceptif
- B. Moteur (muscles, nerfs), sensoriel (fusion) et accommodatif
- C. Cornéen, cristallinien et rétinien
- D. Cortical, sous-cortical et périphérique

Question 40 - Quel est le rôle principal de l'orthoptiste dans la prise en charge du strabisme concomitant ?

- A. Réaliser uniquement la chirurgie des muscles oculomoteurs
- B. Prescrire des médicaments pour réduire l'angle de déviation
- C. Intervenir à toutes les étapes (dépistage, bilan, rééducation, suivi) pour mesurer la déviation, évaluer les fonctions sensorielles et améliorer la vision binoculaire
- D. Effectuer exclusivement les réfractions sous cycloplégie